KIT 4 – DISPNEIA / INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

Referências: ABRAMEDE 2024 • Ministério da Saúde • SBPT • SBC • ACLS 2020 • Protocolo Nacional de Sepse

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem em pacientes com dispneia ou insuficiência respiratória aguda, priorizando a identificação precoce de causas graves e a racionalização dos recursos diagnósticos no pronto-socorro.

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Avaliar **início, duração e progressão da dispneia**, presença de **tosse, febre, dor torácica, sibilância, ortopneia, edema ou sinais de choque**.
- Avaliar **sinais vitais e padrão respiratório** (FR, SpO_2, uso de musculatura acessória, cianose, confusão mental).
- Realizar **oximetria de pulso e ECG de 12 derivações** em todos os casos.
- Iniciar **oxigenoterapia e suporte ventilatório conforme gravidade** (cateter, máscara, VNI, VM).

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Gasometria arterial ou venosa + lactato	Todo paciente com FR > 24 irpm, SpO_2 < 92%, uso de O_2, ou suspeita de acidose / hipercapnia.	Casos leves com saturação normal e dispneia leve ansiosa.
Hemograma completo	Suspeita de infecção (pneumonia, sepse), anemia, hemorragia ou causa hematológica.	Dispneia leve sem sintomas sistêmicos.
Ureia / Creatinina / Eletrólitos	Avaliação metabólica e renal, principalmente em IC, sepse ou uso de diuréticos.	Casos leves, quadro ansioso.
Troponina / CK-MB	Suspeita de SCA, edema agudo de pulmão ou IC aguda descompensada.	Dispneia leve sem dor torácica ou fatores de risco cardíaco.
BNP / NT-proBNP	Dispneia aguda sem diagnóstico definido; suspeita de insuficiência cardíaca.	Paciente com diagnóstico já confirmado ou dispneia não congestiva.
PCR / Procalcitonina	Suspeita de infecção respiratória, pneumonia, sepse.	Dispneia de origem não infecciosa confirmada.
D-Dímero	Suspeita de TEP com escore de Wells ≤ 4.	Solicitação rotineira sem critério clínico.
Função hepática	Pacientes sépticos, hipóxicos graves, IC congestiva.	Casos leves e transitórios.
Glicemia capilar	Todo paciente grave, confuso ou em uso de insulina / betabloqueador.	—

3. EXAMES DE IMAGEM

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
RX de Tórax (PA/AP)	Primeira imagem em todos os casos moderados a graves; pesquisa de pneumonia, edema, derrame, pneumotórax.	Dispneia leve sem repercussão clínica.
USG pulmonar (LUS / POCUS)	Avaliar padrão A/B, derrame pleural, pneumotórax, congestão pulmonar e resposta à terapia.	Casos leves com exame físico e RX normais.
USG cardíaco (POCUS)	Avaliar função ventricular, tamponamento, derrame pericárdico, disfunção VD em suspeita de TEP.	Casos leves com diagnóstico definido.

b) Tomografia Computadorizada (TC)

TC	Indicação (Solicitar se)	Evitar / Não Indicado
TC de Tórax com contraste (Angio-TC)	Suspeita de TEP (Escore de Wells > 4 ou D-dímero positivo).	Dispneia com outra causa já evidente (pneumonia, IC).
TC de Tórax sem contraste	Suspeita de fibrose, infiltrado difuso, neoplasia, COVID prolongado.	Dispneia aguda por causas infecciosas ou cardíacas típicas.

4. ESCORES DE APOIO À DECISÃO

Escore de WELLS – Tromboembolismo Pulmonar

Critério	Pontos
Sinais clínicos de TVP	3,0
TEP mais provável que outro diagnóstico	3,0
FC > 100 bpm	1,5
Cirurgia ou imobilização recente	1,5
História prévia de TEP/TVP	1,5
Hemoptise	1,0
Câncer ativo	1,0

Interpretação:

- ≤ 4 pontos → Baixo risco → Solicitar **D-Dímero**
    - 4 pontos → Alto risco → Solicitar **Angio-TC de Tórax**

5. PRIORIDADES

- Iniciar **oxigenoterapia** conforme SpO_2 (alvo ≥ 94% sem DPOC; 88–92% em DPOC).
- Realizar **ECG e RX de tórax** na abordagem inicial.
- Solicitar **gasometria e lactato** nos casos moderados a graves.
- Aplicar **Escore de Wells** antes de solicitar D-Dímero / TC.
- Evitar duplicidade de exames (RX + TC sem justificativa).

- Reavaliar paciente após intervenções (oxigênio, broncodilatador, diurético, antibiótico).

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
Pneumonia / Sepse Respiratória	Hemograma, PCR, gasometria, eletrólitos	RX Tórax ± USG pulmonar
Edema Agudo de Pulmão / IC	Troponina, BNP, gasometria, eletrólitos	RX Tórax ± Eco POCUS
Asma / DPOC descompensada	Gasometria, eletrólitos	RX Tórax ± USG pulmonar
TEP (suspeita)	D-Dímero (baixo risco) / Angio-TC (alto risco)	TC contrastada
Dispneia psicogênica / leve	Nenhum exame inicial	Nenhum exame inicial

Conclusão

A investigação racional da dispneia deve sempre priorizar a **identificação precoce da insuficiência respiratória**, associando dados clínicos, laboratoriais e de imagem de forma dirigida.

✅ Diagnóstico rápido e direcionado
✅ Menor sobrecarga laboratorial e radiológica
✅ Melhoria do fluxo assistencial
✅ Redução de tempo e custos hospitalares